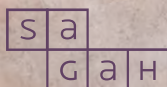


FATURAMENTO E AUDITORIA EM SAÚDE

Bárbara Foiato Hein Machado



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Modelos de remuneração dos serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Explicar os quatro principais modelos de remuneração de serviços de saúde do mundo.
- Descrever as vantagens e as desvantagens de cada modelo de remuneração.
- Exemplificar a utilização de cada um dos modelos de remuneração.

Introdução

Em tempos de instabilidade financeira, gestão de recursos inadequada e mudanças epidemiológicas e demográficas que acometem os sistemas de saúde, muitas reflexões têm surgido acerca das modalidades de remuneração atuantes no setor de saúde. Entre os principais modelos de remuneração dos serviços de saúde do mundo, podemos destacar quatro, quais sejam: *fee for service*, *capitation*, salário ou pagamento fixo mensal e *diagnosis related groups*.

Neste capítulo, você conhecerá as características de cada um desses quatro modelos de remuneração dos serviços de saúde, considerando os benefícios e os prejuízos envolvidos na sua aplicação. Por fim, você estudará exemplos práticos de utilização de cada modelo.

1 Os principais modelos de remuneração dos serviços de saúde

Desde 1990, países ao redor do mundo têm vivenciado transições e combinações entre diversos modelos de remuneração dos serviços de saúde com vistas a identificar qual seria a remuneração mais adequada ao tipo de assistência prestada no serviço (OLIVEIRA; VERAS; CORDEIRO, 2018). Contudo,

a escolha pelo modelo de remuneração mais adequado varia conforme a assistência que se deseja prestar, sendo que “[...] não basta mudar o modelo de remuneração sem modificar também o modelo assistencial e vice-versa. Os dois são interdependentes, caminham juntos e um reforça e é reforçado pelo outro ao longo dos anos” (OLIVEIRA; VERAS; CORDEIRO, 2018, documento *on-line*).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (CAVALCANTE; AGUIAR; PEREIRA, 2019) aponta as principais causas da necessidade de discutir os modelos de remuneração dos serviços de saúde, a saber:

- Modelo de pagamento focado em volume de procedimentos e custos;
- Envelhecimento da população e aumento das doenças crônicas não transmissíveis;
- Custos crescentes e elevados;
- Cuidado descoordenado;
- Fragmentação da rede;
- Fragilidade da mensuração da qualidade em saúde.

Com base nas razões elencadas pela ANS (CAVALCANTE; AGUIAR; PEREIRA, 2019), podemos constatar que questões demográficas, como o envelhecimento da população, e o aumento de doenças crônicas não transmissíveis ocasionam custos maiores aos serviços de saúde, acarretando a sua descoordenação e uma maior ineficiência do cuidado. Por consequência, a rede de saúde fragmenta-se e apresenta maior fragilidade na mensuração da qualidade em saúde, revelando a necessidade de um modelo de pagamento focado no volume dos procedimentos e dos custos. No contexto dos serviços de saúde a nível mundial, muitos países evidenciam que as despesas assistenciais têm crescido juntamente com as despesas dos serviços de saúde devido à incorporação de novas tecnologias e às mudanças demográficas e epidemiológicas já mencionadas. Assim, na esfera internacional, as formas mais frequentes de remuneração dos serviços de saúde são: *fee for service*, *capitation*, salário ou pagamento fixo mensal e *diagnosis related groups*.

O modelo de remuneração *fee for service* — isto é, “**taxa de procedimento ou serviço**”, em português — desconsidera o desempenho, pois interessa-se apenas pela quantidade, sem levar em conta a qualidade. É comum que essa característica torne-se um problema, pois permite que erros médicos e outras ocorrências oriundas da falta de qualidade na prestação dos serviços de saúde também sejam remunerados. Por essa razão, ainda que muitos hospitais continuem a recorrer a esse modelo para efetuar a remuneração dos serviços

prestados nas suas instituições, sendo amplamente conhecido no sistema de saúde, a utilização do *fee for service* tem decaído ao redor do mundo. O pagamento é realizado de forma retrospectiva nesse modelo, podendo ser chamado de pós-pagamento. Nesse sentido, o prestador de serviços é remunerado com base no procedimento realizado, mediante uma tabela de preços previamente definida (BESSA, 2011). Cada procedimento é contabilizado de forma individual, item a item. Ademais, segundo Bessa (2011, documento *on-line*):

No hospital, o modelo de remuneração item a item ocorre com base em uma tabela composta de diárias, taxas de sala, procedimentos de enfermagem, taxas de uso de equipamentos, gasoterapia, etc., além de materiais de consumo e medicamentos utilizados durante a prestação do serviço, bem como honorários médicos, exames e tratamentos realizados durante o atendimento ao paciente internado. Não há controle sobre a quantidade de serviços realizados e quanto mais serviços são executados, maiores são os valores das contas hospitalares.

Já o modelo de remuneração *capitation*, ou *per capita* ocorre quando o pagamento parte de um valor fixo por paciente cadastrado e da expectativa de utilização dos serviços, fato que justifica a associação com a expressão *per capita*, ou “por cabeça”, em português. Esse valor fixo remunera todos os serviços prestados pelo profissional de saúde ao longo de determinado período. Segundo a ANS (CAVALCANTE; AGUIAR; PEREIRA, 2019, documento *on-line*), “[...] o prestador recebe um montante de recursos periodicamente, geralmente anual, que equivale ao número de indivíduos a ele adscritos, multiplicado por um valor *per capita*”. O valor é ajustado conforme as necessidades de cada paciente, de modo que varia conforme os riscos aos quais está propenso, a idade, o gênero e outros aspectos que podem influenciar a utilização dos serviços de saúde (OLIVEIRA; VERAS; CORDEIRO, 2018). Assim, quando há alguma variação nas características dos pacientes, como o surgimento de uma nova doença, é necessário ajustar os valores fixados.

Um terceiro modelo consiste na remuneração por **salário ou pagamento fixo mensal**, também chamado de **assalariamento**. Trata-se de um simples pagamento prospectivo, com valores acordados previamente de acordo com a carga horária, os benefícios e a formação do prestador de serviços. Essa modalidade de remuneração dos serviços de saúde independente da produção e, portanto, não há muito incentivo de produtividade (BESSA, 2011). Há, ainda, possibilidades relevantes de combinação entre esse modelo e outros, que podem atuar sobre essa limitação da produtividade, conforme expõe Andreazzi (2003, documento *on-line*):

Alguns sistemas têm preconizado a associação de incentivos ligados à produtividade dentro do método de remuneração por tempo de trabalho — combinação de salário com pagamento por ato. Os incentivos decorrentes são parecidos ao pós-pagamento por produção: superprodução, frequentemente por meio da redução do tempo gasto com cada paciente, e utilização excessiva de procedimentos de diagnóstico como forma de substituir o exame clínico adequado, ambas com impactos sobre a qualidade.

Por fim, há o modelo de remuneração *diagnosis related groups*, que pode ser traduzido ao português como “**grupo de diagnósticos relacionados**”, também conhecido como **pagamento por pacote**. Esse modelo surgiu como um sistema de classificação de pacientes com o objetivo de monitorar a utilização dos serviços e promover a qualidade da atenção prestada (FETTER, 1991). Atualmente, o *diagnosis related groups* fundamenta-se no pagamento prospectivo, de modo que os valores são apresentados antes que o procedimento ocorra. Nas palavras de Roschel *et al.* (2018, documento *on-line*), “[...] trata-se de uma classificação de pacientes hospitalares que leva em consideração o consumo de recursos, reunindo os pacientes clinicamente homogêneos em um mesmo grupo”. Logo, o pagamento é efetuado com base em casos delimitados conforme a homogeneidade no consumo dos serviços, ou seja, por compatibilidade de características.

Conforme estudamos ao longo desta seção, para conhecer o método de remuneração mais adequado ao serviço de saúde estabelecido, é importante ter em mente o tipo de assistência prestada e os objetivos buscados com vistas a experimentar diferentes abordagens ou combinar os modelos de remuneração. Ademais, podemos notar que há certa tendência a adotar modelos de remuneração dos serviços de saúde baseados na entrega do valor ao paciente, uma vez que a satisfação do cliente com relação ao serviço prestado é uma das preocupações centrais nos serviços de saúde atuais.



Saiba mais

Para saber mais sobre os modelos de remuneração dos serviços de saúde predominantes no mercado e as suas implicações no relacionamento entre as operadoras de saúde e os hospitais, sugerimos a leitura do artigo intitulado “O relacionamento entre hospitais e operadoras de planos de saúde no âmbito do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS”, de Escrivão Júnior e Koyama (2007).

2 Vantagens e desvantagens dos modelos de remuneração

Todo sistema de remuneração possui vantagens e desvantagens na sua aplicação, as quais variam a depender do tipo de assistência prestada, das limitações dos envolvidos, entre outros fatores. No modelo *fee for service*, no qual a remuneração é calculada com base no procedimento ou serviço prestado, uma das principais desvantagens reside em priorizar a quantidade em detrimento da qualidade. Afinal, o desempenho do prestador de serviços não é levado em conta, considerando-se apenas se o procedimento foi realizado ou não. Além disso, tendo em vista que cada procedimento tem um valor financeiro diferente, a variação da remuneração pode ser muito grande, acarretando uma possível distribuição desigual nas remunerações dos profissionais, bem como a preferência por procedimentos de saúde mais custosos, independentemente da necessidade de execução dos mesmos. Bessa (2011) ainda destaca outras desvantagens próprias desse modelo, quais sejam:

- Incentivar o superfaturamento, de modo a resultar em custos exagerados a serem arcados pelo paciente;
- Desfavorecer práticas positivas como a promoção e a prevenção da saúde;
- Ocasionar a distribuição desigual dos médicos com relação às suas especialidades, acarretando a concentração desses profissionais em áreas de maior rentabilidade;
- Estimular a quantidade e a complexidade, sem prezar pela necessidade;
- Aumentar o número de consultas e procedimentos.

Entretanto, muitos profissionais e inúmeras instituições defendem a modalidade *fee for service* com o argumento de que esse tipo de remuneração permite ao médico o cuidado integral do paciente, sem qualquer restrição à quantidade de exames voltados ao diagnóstico e ao tratamento das enfermidades que o levaram a procurar ajuda médica (BESSA, 2011). Somado a isso, podemos verificar como outras vantagens os fatos de que, em geral, esse modelo promove alta satisfação por parte dos profissionais e o seu cálculo é considerado mais simples do que o cálculo dos demais modelos de remuneração (TOBAR; ROSENFELD; REALE, 1998). Ademais, o *fee for service* concede ao paciente maior liberdade de escolha com relação ao médico ou às instituições que deseja consultar, além de haver mais incentivos à integralidade do atendimento e à autonomia clínica nessa proposta.

No que concerne à modalidade de remuneração *capitation*, ou *per capita*, na qual ocorre o pagamento com base no número de pacientes cadastrados e de acordo com variáveis pré-estabelecidas para estimar a expectativa de utilização dos serviços de saúde, podemos destacar como uma vantagem a previsibilidade dos gastos e da receita. Essa vantagem auxilia a restringir os custos e enfoca a atenção à saúde da população. Entre as desvantagens, podemos citar a preferência seletiva por pacientes que tendem a gerar menos custos por serem menos vulneráveis e possuírem riscos de saúde menores, por exemplo. Além disso, também podemos considerar como uma desvantagem da remuneração *capitation*, ou *per capita*, a possibilidade de redução da qualidade e subutilização dos serviços com o intuito de obter ganhos financeiros. Ainda, fontes pagadoras podem tentar limitar certos serviços a determinados prestadores. Para Sória, Bordin e Costa Filho (2002, documento *on-line*), “[...] o risco financeiro do sistema de capitação é transferido ao prestador de serviços, fato que determina o maior controle de custos do comprador”. Os autores também assinalam que:

Vários autores enfatizam que o sistema de capitação pode gerar o subtratamento, ou seja, a não-satisfação das necessidades de tratamento, justamente por funcionar de maneira oposta ao modelo de taxas por serviço. Há motivos racionais para que o profissional deixe de prestar o atendimento necessário, pois assim ele teria maior lucratividade (SÓRIA; BORDIN; COSTA FILHO, 2002, documento *on-line*).

Já na remuneração por **salário ou pagamento fixo mensal**, em que o pagamento é executado de forma prospectiva de acordo com critérios pré-acordados, Chiavenato (2002 *apud* SABINO; CUNHA, 2016) identifica as seguintes vantagens:

- Facilidade no equilíbrio interno da instituição, através de um sistema de cargos e salários;
- Facilidade no equilíbrio externo, por meio de pesquisa dos salários em outras organizações;
- Homogeneização e padronização dos salários;
- Facilidade na gestão e controle dos custos.

Como desvantagem, o autor (CHIAVENATO, 2002 *apud* SABINO; CUNHA, 2016) indica que a remuneração por salário ou pagamento fixo mensal tende a ocasionar falta de motivação, porque é previsível e rotineira. Como não há incentivo à produtividade, verifica-se baixo nível de entrega de serviços.

Por sua vez, a modalidade *diagnosis related groups*, um tipo de remuneração baseada em um sistema de classificação de casos, também tem as suas vantagens e as suas desvantagens no que tange à aplicação. Embasados em análises de estudos desenvolvidos em países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, Roschel *et al.* (2018, documento *on-line*) concluíram que:

Os pontos positivos do sistema de pagamento DRG são o aumento da eficiência na assistência ao paciente e transparência das informações, assim como na redução da duração média da estadia dos pacientes nos hospitais. Já os pontos fracos evidenciados foram criações de incentivos financeiros para altas hospitalares precoces.

Portanto, ao passo que o pagamento por *diagnosis related groups* permite a redução de custos e diminui o tempo de permanência hospitalar por parte do paciente, o método também incentiva que os serviços de saúde sejam concluídos em pouco tempo, podendo gerar baixa qualidade no tratamento.

Em suma, podemos compreender que cada modelo de remuneração dos serviços de saúde possui as suas próprias particularidades, incluindo uma série de vantagens e desvantagens. Dessa maneira, cabe às instituições fazer o levantamento das suas necessidades e dos objetivos que almeja alcançar para poder escolher o modelo que melhor atenda à sua estrutura, ao tipo de assistência prestada e às suas limitações. O Quadro 1, a seguir, apresenta a síntese dos conteúdos que estamos nesta seção. Nele, podemos observar quais são as principais vantagens e as principais desvantagens de cada um dos quatro modelos centrais de remuneração dos serviços de saúde.

Quadro 1. Principais vantagens e desvantagens dos modelos de remuneração em saúde

Modelo	Características	Principais vantagens	Principais desvantagens
<i>Fee for service</i>	Pagamento por serviço ou procedimento executado.	Quantidade ilimitada de procedimentos ou exames diagnósticos; Incentivo do cuidado integral do paciente; Promoção de maior autonomia clínica.	Custos exagerados e risco de superfaturamento; Concentração de profissionais em especialidades médicas com maior rentabilidade, ocasionando distribuição desigual de médicos; Preferência por menor qualidade e maior quantidade de procedimentos.
<i>Capitation</i>	Pagamento por valor fixo determinado a um paciente cadastrado, de acordo com a expectativa de uso dos serviços.	Facilidade na previsão de gastos e receitas; Maior clareza na redução de custos.	Subutilização de serviços e consequente redução da qualidade dos serviços prestados.
<i>Salário ou pagamento fixo</i>	Remuneração tradicional, com pagamento prospectivo, a partir de critérios pré-estabelecidos, tais como benefícios, carga horária, formação do profissional, etc.	Promoção de maior equilíbrio interno e externo da instituição; Homogeneização e padronização dos pagamentos, possibilitando maior controle de custos.	Previsível e rotineira, podendo levar à falta de motivação por parte dos profissionais de saúde.
<i>Diagnosis related groups</i>	Pagamento mediante um sistema de classificação de casos, segundo variáveis como gênero, idade, etc.	Maior eficiência no cuidado, visto que há mais clareza sobre as informações do paciente; Maior transparência de informações; Menos custos com internações hospitalares.	Incentivo a altas hospitalares o mais breve possível, podendo diminuir a qualidade do tratamento.



Saiba mais

Para aprofundar os seus conhecimentos sobre a participação dos modelos de remuneração nos serviços de saúde público e privado no Brasil, considerando as contribuições e as limitações de cada um, recomendamos que você leia o capítulo 7 da obra *Sistema de Saúde no Brasil: organização e financiamento*, intitulado “A provisão dos serviços e ações do SUS: participação de agentes públicos e privados e formas de produção/remuneração dos serviços”, de Santos e Servo (2016).

3 Os modelos de remuneração na prática

Os sistemas de saúde consomem muitos recursos, de modo que a adoção do modelo de remuneração mais adequado ao contexto de cada instituição converte-se em uma peça-chave para a eficiência dos serviços prestados. Dessa maneira, cabe a cada instituição de saúde avaliar qual é o melhor método de pagamento dos seus profissionais. Além disso, diversos estudos têm analisado a aplicação de modelos de remuneração dos serviços de saúde, sendo importante que o gestor de custos na área tenha conhecimento sobre como tais sistemas são utilizados na prática.

Um dos modelos de remuneração mais utilizados no mundo, sobretudo no Brasil, nos contratos entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço é o *fee for service*. Costa e Arrais (2018, documento *on-line*) explicitam que:

Tanto nos hospitais públicos, quanto nos hospitais privados esse modelo de faturamento é feito de forma em que cada item utilizado na internação do paciente é detalhado na conta, após um processo de faturamento em que profissionais de saúde contratados pelo hospital analisam a internação.

Posto que a remuneração é feita a partir do serviço ou procedimento executado, é comum que os profissionais concentrem os serviços ou os procedimentos em áreas que geram mais lucratividade, com a adoção de procedimentos mais complexos e insumos excessivos que serão contabilizados. Conforme estudamos ao longo deste capítulo, esse modelo de remuneração incentiva a quantidade, não a qualidade. Por causa dessa desvantagem, diversos hospitais

e planos de saúde estão substituindo o modelo tradicional *fee for service* por alternativas que facilitem a previsão de custos e qualifiquem o desempenho dos serviços. Nesse sentido, uma alternativa ao *fee for service* deve pautar-se pelo valor ou pelo benefício gerado pelo serviço, não pela quantidade, como esse modelo promove (COSTA; ARRAIS, 2018).

Entretanto, o *fee for service* tem sido empregado em combinação com outros métodos, como o *capitation*. A ANS (CAVALCANTE; AGUIAR; PEREIRA, 2019) informa que, em combinação com o *fee for service*, o *capitation* vem sendo aplicado em serviços de atenção primária na Espanha, em Portugal, na Suíça, na Bélgica e na Holanda, sendo que cada país varia apenas os ajustes de riscos. Em Portugal e na Suíça, por exemplo, os ajustes do modelo adequam-se à idade, ao gênero, às condições de saúde e à utilização prévia do serviço por parte do cliente. Já na Espanha, os ajustes ocorrem em função da idade, da densidade e da dispersão.

Por outro lado, um sistema de remuneração dos serviços de saúde bastante comum nos Estados Unidos é o **salário ou pagamento mensal**, tal como ocorre na Mayo Clinic, uma instituição de serviços de saúde bastante popular no país por causa da alta qualidade e dos baixos custos dos atendimentos prestados (CAVALCANTE; AGUIAR; PEREIRA, 2019). Uma pesquisa realizada pela organização com o intuito de verificar o desempenho associado à remuneração por salário constatou que havia igualdade salarial entre 96% dos 2.845 médicos que trabalham na Mayo Clinic, o que foi considerado um sucesso pela organização. Ademais, vale destacarmos que esse modelo também é predominante no pagamento dos profissionais de saúde do SUS (BESSA, 2011).

No que tange ao modelo de remuneração denominado *diagnosis related groups*, podemos notar que ele foi incorporado inicialmente pelo Medicare — um sistema de seguros de saúde estadunidense — e pelo Medicaid — um programa de saúde social também dos Estados Unidos. Os países desenvolvidos foram os primeiros a adotar esse método e, hoje em dia, países como Noruega, Alemanha, Holanda e Suíça também o utilizam amplamente com o propósito de aumentar a eficiência dos serviços e procedimentos executados, além de controlar os custos gerados por tais atendimentos (ROSCHER *et al.*, 2018).

No Brasil, podemos verificar a crescente adesão ao método *diagnosis related groups* com vistas a melhorar os resultados nos serviços de saúde. Entre as instituições que aderiram a esse modelo de remuneração, podemos citar a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (Unimed). De acordo com Negri Filho e Fonseca (2015, documento *on-line*):

Por meio de uma classificação detalhada do produto hospitalar, é estabelecido um preço fixo por procedimentos ou diagnósticos baseado em valores médios. O incentivo, para o hospital, é manter o seu custo de tratamento do caso abaixo do preço estabelecido em tabela, seja aumentando a eficiência (utilizando melhor os recursos empregados no caso), seja, no limite, utilizando menos recursos do que seria adequado.

Os autores também destacam que os custos dos diagnósticos podem variar de acordo com idade, sexo, entre outras variáveis (NEGRI FILHO; FONSECA, 2015). Negri Filho e Fonseca (2015) apontam, ainda, que é comum a prática de transferência ou desvio de pacientes com determinados problemas de saúde no sistema de saúde privado brasileiro com o possível intuito de diminuir as taxas de hospitalização e permanência no hospital, constatando a existência de uma das principais desvantagens do *diagnosis related groups*. Cabe atentarmos ao fato de que a remuneração do SUS para internações assemelha-se a esse modelo, recebendo a denominação de **remuneração por procedimento**. Por intermédio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), o prestador de serviços tem acesso ao valor a ser pago por cada tipo de procedimento realizado.

A utilização dos modelos de remuneração dos serviços de saúde é bastante heterogênea no mundo, variando conforme o país, o tipo de instituição, os objetivos da organização e as características da população. Todavia, é consenso entre os estudiosos do assunto que a combinação de métodos é mais eficiente do que a adoção de um único método, dada a complexidade da prestação de serviços nesse setor. Portanto, é importante que os gestores conheçam como tais modalidades são aplicadas e saibam identificar os casos de sucesso com vistas a experimentar novas abordagens e qualificar os serviços de saúde.



Saiba mais

Para conhecer mais detalhes sobre a aplicação dos modelos de remuneração dos serviços de saúde, indicamos que você leia o trabalho “Percepção dos gestores de empresas de saúde suplementar de Porto Alegre sobre os diferentes modelos de remuneração assistencial”, de Holstein (2019). No referido material, o autor discute a percepção de gestores sobre alguns dos principais modelos de remuneração na saúde suplementar de Porto Alegre, verificando os seus impactos nos custos assistenciais.



Referências

ANDREAZZI, M. de F. S. de. Formas de remuneração de serviços de saúde. *Texto para Discussão*, n. 1006, dez. 2003. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1006.pdf. Acesso em: 11 jul. 2020.

BESSA, R. de O. *Análise dos modelos de remuneração médica no setor de saúde suplementar brasileiro*. 2011. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2011. Disponível em: https://pesquisa-eaesf.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/ricardo_de_oliveira_bessa.pdf. Acesso em: 11 jul. 2020.

CAVALCANTE, A. P. S.; AGUIAR, R.; PEREIRA, D. (coord.). *Guia para implementação de modelos de remuneração baseados em valor*. Rio de Janeiro: ANS, 2019. Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/Guia_-_Modelos_de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_Baseados_em_Valor.pdf. Acesso em: 11 jul. 2020.

COSTA, E. P. da S. R.; ARRAIS, A. da R. Proposta de faturamento hospitalar alternativo ao pagamento *fee for service*, aplicado ao serviço de parto: pela sustentabilidade do sistema. In: 1º PRÊMIO ANS: concurso de monografia sobre saúde suplementar. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <http://repositorio.fepecs.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/117>. Acesso em: 11 jul. 2020.

FETTER, R. B. *The DRG patient classification system – background*. In: FETTER, R. B.; BRAND, D. A.; GAMACHE, D. (ed.). *DRGs their design and development*. Ann Arbor: Health Administration Press, 1991.

NEGRI FILHO, A. A. de.; FONSECA, F. C. S. da. *Modelos de financiamento e remuneração da atenção à saúde pública no Brasil*. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad, 2015. Disponível em: <http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:501056>. Acesso em: 11 jul. 2020.

OLIVEIRA, M. R. de; VERAS, R. P.; CORDEIRO, H. A. O modelo de remuneração definindo a forma de cuidar: por que premiar a ineficiência no cuidado ao idoso? *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, v. 10, n. 2, ago. 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-915120>. Acesso em: 11 jul. 2020.

ROSCHER, L. F. et al. Eficiência nos gastos dos hospitais: um estudo sobre o sistema Diagnosis Related Groups (DRG). *Revista de Gestão em Sistemas de Saúde*, v. 7, n. 2, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=revistargss&page=article&op=view&path%5B%5D=12802>. Acesso em: 11 jul. 2020.

SABINO, L. A. M.; CUNHA, N. C. Remuneração e salário numa abordagem administrativa. *Revista GeTeC*, v. 5, n. 10, 2016. Disponível em: <http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/getec/article/view/785>. Acesso em: 11 jul. 2020.

SÓRIA, L.; BORDIN, R.; COSTA FILHO, L. C da. Remuneração dos serviços de saúde bucal: formas e impactos na assistência. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 18, n. 6, 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2002000600008&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 11 jul. 2020.

TOBAR, F.; ROSENFELD, N.; REALE, A. *Modelos de pago en servicios de salud*. *Cuaderno Médicos Sociales*, n. 74, 1998. Disponível em: https://www.academia.edu/36657656/Modelos_de_Pago_en_servicios_de_salud. Acesso em: 11 jul. 2020.

Leituras recomendadas

ESCRIVÃO JUNIOR, A.; KOYAMA, M. F. O relacionamento entre hospitais e operadoras de planos de saúde no âmbito do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, n. 4, jul./ago. 2007. Disponível em: <https://search.proquest.com/openview/5af9c6fde9dbc740f1901a127eb4297/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034998>. Acesso em: 11 jul. 2020.

HOLSTEIN, M. X. *Percepção dos gestores de empresas de saúde suplementar de Porto Alegre sobre os diferentes modelos de remuneração assistencial*. 2018. 40 f. Trabalho de conclusão (Graduação) - Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/203788>. Acesso em: 11 jul. 2020.

SANTOS, M. A. B dos.; SERVO, L. M. S. A provisão dos serviços e ações do SUS: participação de agentes públicos e privados e formas de produção/remuneração dos serviços. In: MARQUES, R. M.; PIOLA, S. F.; CARRILLO ROA, A. (org.). *Sistema de saúde no Brasil: organização e financiamento*. Rio de Janeiro: MS, 2016. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude_brasil_organizacao_financiamento.pdf. Acesso em: 11 jul. 2020.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS